Lire un rapport AGP en 4 questions

Capteur de glucose (FreeStyle Libre, Dexcom…) : hypoglycémies, temps dans la cible, GMI
EHPAD · FAM · MAS · USLD — médecins DOTR, IDE, IDEC

FICHE PRATIQUE DOTR · DIABÈTE
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

À RETENIR

Toujours lire dans le même ordre : données suffisantes → hypoglycémies → temps dans la cible → GMI. La première priorité est de réduire le temps passé en hypoglycémie, surtout chez le sujet âgé.

Sources : Battelino T et al., consensus international Time in Range, Diabetes Care 2019;42:1593-1603 · SFD, prise de position 2023 (Darmon P et al., Méd Mal Métab 2023, doi 10.1016/j.mmm.2023.10.007), tableaux I et II ; mise à jour 2025 (doi 10.1016/j.mmm.2025.10.002) · Johnson ML et al., lecture de l'AGP en 9 étapes, Diabetes Technol Ther 2019

1 · Les objectifs (SFD 2023) — à individualiser

Indicateur (rapport AGP)	Cas général	Sujet âgé fragile ou à risque d'hypoglycémie
Temps dans la cible : 0,70 à 1,80 g/L (TIR)	> 70 %	> 50 %
Temps sous la cible : < 0,70 g/L (TBR)	< 4 %	< 1 %
Hypoglycémie de niveau 2 : < 0,54 g/L	< 1 %	0 %
Temps au-dessus : > 1,80 g/L (TAR)	< 25 %	< 50 %
Hyperglycémie marquée : > 2,50 g/L	< 5 %	< 10 %

Sources : SFD, prise de position 2023 (Darmon P et al., Méd Mal Métab 2023, doi 10.1016/j.mmm.2023.10.007), tableaux I et II ; mise à jour 2025 (doi 10.1016/j.mmm.2025.10.002) · Battelino T et al., consensus international Time in Range, Diabetes Care 2019;42:1593-1603

Repères : 1 % du temps ≈ 15 min par jour · 0,70 g/L = 70 mg/dL = 3,9 mmol/L · 1,80 g/L = 10 mmol/L · 0,54 g/L = 3,0 mmol/L · 2,50 g/L = 13,9 mmol/L · variabilité : coefficient de variation (CV) ≤ 36 % (consensus 2019).

2 · L'arbre de décision

① Données suffisantes ?
Au moins **14 jours** d'enregistrement, capteur actif ≥ **70 %** du temps.

NON → **Interpréter avec prudence**
- Vérifier le port du capteur, les pertes de signal, les scans (FreeStyle Libre) ; relire sur une période plus longue avant de modifier le traitement.

OUI ↓

② Trop d'hypoglycémies ?
Temps **< 0,70 g/L** au-dessus de l'objectif : **> 4 %** (≈ 1 h/j) ; sujet âgé fragile : **> 1 %** (≈ 15 min/j). Ou temps **< 0,54 g/L** > 1 % (fragile : **tout épisode**).

OUI → **PRIORITÉ ABSOLUE : réduire les hypoglycémies**
- Repérer **quand** : nuit, fin d'après-midi, repas sauté ou peu mangé ?
- **Réduire ou arrêter** la molécule en cause : insuline, sulfamide, glinide ; vérifier apports, poids, DFG.
- **Ne pas intensifier** le traitement, même si le temps dans la cible est bas.
- Creux nocturne isolé sans symptôme : penser à la **compression du capteur** (résident couché dessus), confirmer au doigt.

NON ↓

③ Temps dans la cible atteint ?
Entre **0,70 et 1,80 g/L** : **> 70 %** du temps (≈ 17 h/j) ; sujet âgé fragile : **> 50 %** (≈ 12 h/j).

OUI → **Objectif atteint : ne rien intensifier**
- Poursuivre, rapport AGP à chaque réévaluation.
- Sujet âgé fragile ou dépendant : se demander si le traitement n'est pas **plus lourd que nécessaire** (désintensification).

NON ↓

④ Où se situe l'hyperglycémie ?
Lire la **courbe AGP** heure par heure : quand la médiane dépasse **1,80 g/L** ?

→ **Adapter au moment de la journée**
- **Après les repas** : repas concerné, traitement prandial · **nuit et réveil** : traitement du soir, insuline basale.
- **Toute la journée** : traitement de fond, dose réellement administrée.
- Chercher une cause : infection, corticoïdes, déshydratation, alimentation.

Fiche DOTR. Objectifs à individualiser : ils ne remplacent ni le jugement clinique ni l'avis du diabétologue. Rapport AGP = profil glycémique ambulatoire.

3 · Lire la courbe AGP et le GMI

LA COURBE AGP : UNE JOURNÉE TYPE

- **Ligne foncée = médiane** : la glycémie « habituelle » à chaque heure, tous jours confondus.
- **Zone foncée** : la moitié des valeurs (25e–75e percentile) ; **zone claire** : 90 % des valeurs.
- **Bande large** = glycémie qui change beaucoup d'un jour à l'autre : chercher les repas irréguliers, les oublis, les resucrages excessifs.
- Repérer **l'heure** où la courbe passe sous 0,70 g/L ou au-dessus de 1,80 g/L : c'est là qu'il faut agir.
- Regarder aussi les **profils quotidiens** : un creux isolé n'a pas la même valeur qu'un creux répété.

Sources : Johnson ML et al., lecture de l'AGP en 9 étapes, Diabetes Technol Ther 2019 · Battelino T et al., consensus international Time in Range, Diabetes Care 2019;42:1593-1603

LE GMI : UNE HbA1c ESTIMÉE

GMI (%) = 3,31 + 0,02392 × glycémie moyenne (mg/dL). Exemple : moyenne 1,54 g/L → GMI ≈ 7,0 %.

- **Pas d'objectif propre** : le comparer à l'**objectif d'HbA1c du patient** (tableau ci-dessous).
- Un écart GMI–HbA1c de **0,5 point ou plus est fréquent** : ce n'est pas une erreur, se fier au profil AGP.
- HbA1c moins fiable (anémie, transfusion récente, insuffisance rénale sévère) : le temps dans la cible et le GMI prennent le relais.

Sources : Bergenstal RM et al., Glucose Management Indicator, Diabetes Care 2018;41:2275-2280 · Joubert M, …, Meyer L. Groupe d'experts, MCG chez les DT2 en France, Méd Mal Métab 2025 (doi 10.1016/j.mmm.2025.04.002)

4 · Objectifs d'HbA1c chez le sujet âgé (SFD 2023)

Profil	Objectif d'HbA1c	Sous sulfamide, glinide ou insuline
> 75 ans en bonne santé	≤ 7 %	—
> 75 ans fragile	≤ 8 %	Ne pas descendre **sous 7 %**
> 75 ans dépendant, santé très altérée	< 9 % et/ou glycémie avant repas 1 à 2 g/L	Ne pas descendre **sous 7,5 %** (glycémie avant repas > 1,40 g/L)

Sources : SFD, prise de position 2023 (Darmon P et al., Méd Mal Métab 2023, doi 10.1016/j.mmm.2023.10.007), tableaux I et II ; mise à jour 2025 (doi 10.1016/j.mmm.2025.10.002)

LE CAPTEUR : POUR QUI, PRESCRIT PAR QUI ?

- DT2 sous **insuline non intensifiée** (moins de 3 injections par jour) avec **HbA1c ≥ 8 %** : FreeStyle Libre 2 remboursé depuis 2023.
- **Prescription initiale possible par le médecin généraliste** ; **période d'essai** de 1 à 3 mois avant la prescription au long cours.
- Résident non autonome : le capteur peut être **posé et lu par l'IDE** ou un aidant.
- Autres dispositifs et indications : vérifier la LPP à jour sur ameli.fr.

Sources : Arrêté du 08/06/2023 (JO du 13/06/2023) · avis HAS du 18/10/2022 — FreeStyle Libre 2 · Joubert M, …, Meyer L. Groupe d'experts, MCG chez les DT2 en France, Méd Mal Métab 2025 (doi 10.1016/j.mmm.2025.04.002)

EN ÉTABLISSEMENT : LES BONS RÉFLEXES

- Rapport AGP **sur 14 jours**, imprimé ou joint au dossier avant la téléconsultation.
- L'IDE note les **resucrages** et les **repas non pris** : ils expliquent souvent les creux et les pics.
- Une alarme d'hypoglycémie se **contrôle au doigt** si le résident a des symptômes.
- Après chaque changement de traitement : **nouveau rapport AGP** à 2 semaines.

Sources : lecture DOTR

Références

- Société francophone du diabète (SFD) — Darmon P et al., prise de position 2023 sur les stratégies d'utilisation des traitements de l'hyperglycémie dans le DT2, Méd Mal Métab 2023 (tableau I : objectifs d'HbA1c du sujet âgé ; tableau II : objectifs de temps dans la cible) ; mise à jour 2025, Méd Mal Métab 2025.
- Battelino T et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care 2019;42:1593-1603.
- Bergenstal RM et al. Glucose Management Indicator (GMI). Diabetes Care 2018;41:2275-2280 · Johnson ML et al. Utilizing the AGP report: 9 steps. Diabetes Technol Ther 2019.
- Joubert M et al. (groupe d'experts) Utilisation de la mesure en continu du glucose chez les patients vivant avec un DT2 en France. Méd Mal Métab 2025, doi 10.1016/j.mmm.2025.04.002.
- Arrêté du 08/06/2023 (JO du 13/06/2023) et avis HAS du 18/10/2022 : FreeStyle Libre 2, patients DT2 sous insulinothérapie non intensifiée.